EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77446
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2024-01-16 10:22:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: YOLANDA TORRES BRIONES			**RUN**	: 5.321.297-2
F.Nac	: 22-12-1943	**Edad**	: 80 AÑOS	**Género**	: Femenino
Dirección	: ARTESANOS S/N SAN GREGORIO			**Comuna**	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 68225786		
Fecha Ingreso	: 2024-01-13	**Fecha Egreso**	: 2024-01-16 10:22:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Infección Urinaria por Escherichia coli
- AKI KDIGO I
-DM2, -artrosis,
-DLP, -Ca de mama y útero
- HIC parietotemporal derecha con vaciamiento ventricular, ICH

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 80 años con Antecedentes mórbidos -DM2, -artrosis, -DLP, -Ca de mama y útero - HIC parietotemporal derecha con vaciamiento ventricular, ICH en, hospitalizada recientemente dada de alta con HODOM 9-1-24 para completar tto kine. Medicamentos con Losartan 50 mg cada 12 horas, vía oral. Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, vía oral. Amlodipino 10 mg, 1 comp al día, vía oral.
Familiar niega fiebre, y refiere diuresis con normalidad, deposiciones con normalidad. Es derivada de hodom Por Presentar Mayor Compromiso Del Estado General, orinas concentradas de mal olor Ingresa HDN estable. PA127/80mmhg Sat93% Fc90lpm HGT 161mg/dl.
TAC cerebro 02/01: TC de encéfalo sin contraste: extenso hematoma PT derecho de aprox 60 mL, con vaciamiento ventricular, sin hidrocefalia significativa. TAC cerebro control 12/01/24: similar tamaño, menor densidad y leve mayor edema vasogénico del hematoma intraparenquimatoso subagudo parietotemporal derecho. Laboratorio 13/01/24: Crea 1.3 (previa 0.7 08/01/24), Na 133, PCR 131, GB 11.500, OC inflamatoria, turbia. Pend UC. Se Ingresa Para Manejo Con Atb Ev
Mejoría de la función Renal crea 0,70 clearence 80,51 ,Orinas menos concentradas, hemodinamia estable, yugulares planas, tórax hipo expansible mp presente s con estertores dispersos, rr2ts, abdomen plano blando no doloroso, eei edema + , neurológico vigil, Glasgow 15 ptos, hemiparesia secuelar, por buena evolución se decide hospitalización domiciliaria

PLAN DE MANEJO:

Hospitalizar en HODOM
Mantener tto ATB de primera linea
Mantener kine
Continuar con tto crónico

INDICACIONES AL ALTA

1. Régimen: Liviano Papilla Hiposodico Diabetico.

2. Hidratación via oral 1500 cc dia
3. Kine Motora
4. Ceftriaxona 2 Gr Al Dia por 7 dias ev
5. Espercil 1 amp dia por 5 dias ev
6. Paracetamol 500 Mg, 2 Comp C/8 Hrs por 3 dias Vo
7. Losartan 50 Mg Cada 12 Horas, Vía Oral.
8. Hidroclorotiazida 50 Mg, 1/2 Comp Al Día, Vía Oral.
9. Amlodipino 10 Mg, 1 Comp Al Día, Vía Oral.
10. Control sos Urgencia

EXÁMENES Y RESULTADOS

Urocultivo - Aislamiento : Escherichia coli Ampicilina : Sensible (CIM: <=4 ug/mL)
Ciprofloxacino : Sensible (CIM: <=0,125 ug/mL) Ceftriaxona : Sensible (CIM: <=1 ug/mL)
Cefazolina : Sensible (CIM: <=2 ug/mL) Nitrofurantoína : Sensible (CIM: <=16 ug/mL)

Proteina C Reactiva : 10,9
Creatinina : 0,70 mg/dl 0,52 - 1,04
Clearence Calculado(MDRD) : 80,51
Sodio (Na) : 138,00 mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio (K) : 3,70 mmol/L 3,50 - 5,50
Cloro (Cl) : 109,00
Sodio (Na) : 138,00 mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio (K) : 3,70 mmol/L 3,50 - 5,50
Cloro (Cl) : 109,00

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO